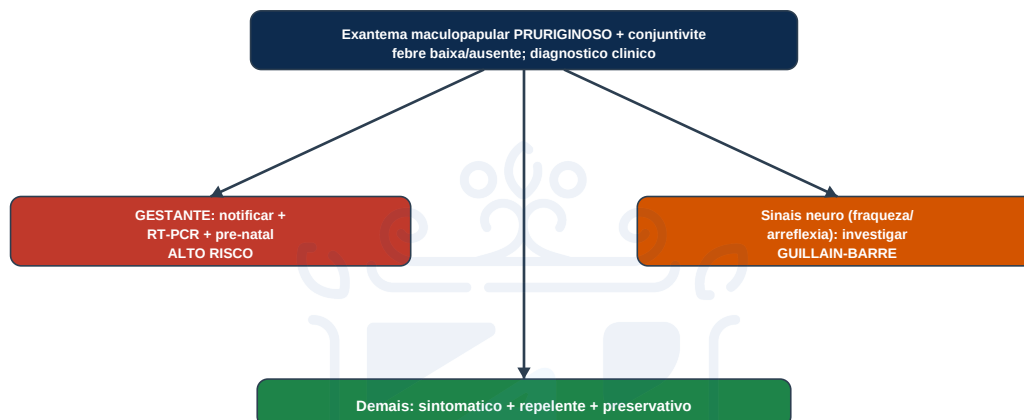


ZIKA — EXANTEMA + GESTANTE = PRIORIDADE

FLUXOGRAMA — ABORDAGEM

ZIKA — DIAGNÓSTICO CLÍNICO + TRIAR GESTANTE/NEURO



DEFINIÇÃO E TRANSMISSÃO

O QUE É

- Arbovirose pelo vírus Zika (ZIKV), transmitida pelo *Aedes aegypti*; 80% assintomáticos ou doença febril leve autolimitada
- Quadro semelhante a dengue/chikungunya, porém mais LEVE; incubação 3-14 dias
- Transmissão: picada (principal), VERTICAL (mãe-feto, risco de MICROCEFALIA), SEXUAL (sêmen até 6 meses), transfusional (raro)
- Associações importantes: microcefalia congênita (gestantes) e síndrome de Guillain-Barré (SGB)
- CHAVE: diagnóstico clínico + exantema maculopapular pruriginoso + GESTANTE = alto risco (encaminhar pré-natal de alto risco)

DIFERENCIAÇÃO ENTRE ARBOVIROSES

Sintoma	Zika	Dengue	Chikungunya
Febre	Baixa/ausente	Alta (39-40)	Alta (39-40)
Exantema	Intenso, PRURIGINOSO	Discreto	Discreto/ausente
Conjuntivite	Comum (não purulenta)	Rara	Rara
Artralgia	Leve-moderada	Leve	INTENSA (incapacitante)

CASO SUSPEITO E EXAME FÍSICO

O QUE BUSCAR

- Caso suspeito: exantema maculopapular pruriginoso + ≥ 1 de: febre (baixa/ausente), hiperemia conjuntival sem secreção, artralgia/mialgia, edema periarticular
- Pele: exantema com início na face e disseminação craniocaudal, pruriginoso (diferente da dengue), pode descamar
- Olhos: hiperemia conjuntival bilateral, sem secreção purulenta, sem dor ocular
- Articulações: artralgia/edema em mãos, punhos, tornozelos (leve-moderada, NÃO incapacitante como chikungunya)
- Neurológico: avaliar SGB (fraqueza ascendente, parestesias, arreflexia)

GESTANTES — PRIORIDADE ABSOLUTA

RISCO DE MICROCEFALIA

- Risco de microcefalia e malformações fetais (especialmente 1º trimestre)
- No PS: NOTIFICAR imediatamente, solicitar RT-PCR Zika (sangue + urina), ENCAMINHAR para pré-natal de alto risco (urgente)
- Orientar repelente (DEET/icaridina, seguros) e preservativo durante toda a gestação
- Seguimento: USG obstétrico seriado (perímetro cefálico, calcificações, ventriculomegalia); RT-PCR de líquido amniótico se alterações
- Planejamento de gravidez: aguardar 8 semanas após os sintomas (mulher); parceiro 8 semanas (ou 6 meses se sêmen PCR+)

EXAMES COMPLEMENTARES

NÃO DE ROTINA

- Diagnóstico é clínico-epidemiológico; exames NÃO de rotina
- RT-PCR Zika (sangue até 5º dia / urina até 14º dia): gestantes, casos neurológicos, graves/atípicos, vigilância
- Sorologia IgM/IgG após o 5º dia — pode ter reação cruzada com dengue/febre amarela
- Hemograma inespecífico: pode ter leucopenia/linfocitose relativa, SEM hemoconcentração (diferente da dengue)
- Sintomas neurológicos: punção lombar e eletroneuromiografia (investigar Guillain-Barré)

TRATAMENTO (100% SINTOMÁTICO)

Rx SEM ANTIVIRAL ESPECÍFICO

Repouso relativo; afastamento por ~7 dias
Hidratação oral abundante (2-3 L/dia); não requer hidratação EV (doença leve)
Analgesia/febre: Paracetamol 750 mg 6/6h (1ª escolha, seguro na gestante) ou Dipirona 500-1000 mg 6/6h
Prurido intenso: Loratadina 10 mg/dia ou Hidroxizina 25 mg 8/8h por 3-5 dias
Medidas: repelente (DEET/icaridina), barreira contra mosquitos (telas/ar-condicionado), preservativo por 8 semanas
ATENÇÃO: na suspeita de dengue concomitante, evitar AINE/AAS

INTERNAÇÃO, ALTA E ALARME

DECISÃO

- ☐ INTERNAR (raro): suspeita de Guillain-Barré, meningoencefalite, gestante com complicação (TPP, sofrimento fetal), criança < 3 meses com febre e exantema, impossibilidade de seguimento
- ☐ ALTA: quadro leve sem complicações, sem sinais de dengue/chikungunya grave, sem sinais neurológicos, gestante com encaminhamento garantido ao pré-natal de alto risco
- ☐ Retorno em 7 dias se não melhorar (ou antes se piora)
- ☐ ALARME (retorno imediato): fraqueza muscular (pernas), dificuldade de andar/respirar, parestesia/arreflexia (Guillain-Barré); rigidez de nuca/cefaleia intensa/vômitos (meningite); sangramento/dor abdominal (suspeitar dengue)
- ☐ Gestantes: contrações, sangramento vaginal, redução de movimentos fetais

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente com Zika: exantema maculopapular pruriginoso há ____ dias, febre ____ (baixa/ausente), conjuntivite ____, artralgia em ____; gestante de ____ semanas / não gestante.
- RT-PCR Zika ____ (coletado?); sinais neurológicos (fraqueza/arreflexia) ____; sinais vitais ____.
- Gestante: encaminhada ao pré-natal de alto risco; USG obstétrico ____.
- Solicito internação para ____ (investigação de Guillain-Barré / seguimento de gestação de alto risco / complicação neurológica).

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Qual achado clínico é mais característico da infecção por Zika, ajudando a diferenciá-la da dengue?

- A) Febre alta com mialgia intensa
- B) Exantema maculopapular pruriginoso com hiperemia conjuntival não purulenta
- C) Artralgia incapacitante
- D) Hemoconcentração
- E) Petéquias com prova do laço positiva

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Por que a gestante com Zika é prioridade absoluta?

- A) Risco de choque hipovolêmico
- B) Risco de microcefalia e malformações fetais (transmissão vertical)
- C) Risco de artrite crônica
- D) Risco de hepatite
- E) Não há risco especial

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual complicação neurológica está associada à infecção pelo vírus Zika?

- A) Esclerose múltipla
- B) Síndrome de Guillain-Barré
- C) Doença de Parkinson
- D) Miastenia gravis
- E) Esclerose lateral amiotrófica

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Qual orientação é correta quanto à transmissão sexual do Zika?

- A) Não há transmissão sexual
- B) Usar preservativo por 8 semanas após os sintomas (vírus persiste no sêmen)
- C) Apenas evitar beijo
- D) Transmissão só por transfusão
- E) Não há necessidade de qualquer medida

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual é o tratamento da infecção por Zika não complicada?

- A) Antiviral específico
- B) Sintomático: repouso, hidratação, paracetamol/dipirona e anti-histamínico se prurido
- C) Antibiótico
- D) Corticoide sistêmico
- E) Imunoglobulina

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

O exantema maculopapular pruriginoso com hiperemia conjuntival não purulenta e febre baixa/ausente é o quadro mais característico do Zika, diferenciando-o da dengue (febre alta, mialgia intensa).

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A gestante é prioridade pelo risco de microcefalia e malformações fetais por transmissão vertical (sobretudo no 1º trimestre), exigindo notificação, RT-PCR e pré-natal de alto risco.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A síndrome de Guillain-Barré é a complicação neurológica associada ao Zika; suspeitar diante de fraqueza ascendente, parestesias e arreflexia.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

O vírus persiste no sêmen, por isso se orienta uso de preservativo por 8 semanas após os sintomas (ou mais se sêmen PCR+).

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Não há antiviral específico; o tratamento é sintomático (repouso, hidratação, paracetamol/dipirona e anti-histamínico se prurido), além de medidas de prevenção da transmissão.

SM24
Suporte ao Plantão Médico